

Первая центральная больница Тяньцзиня

Международный медицинский центр

Профессиональная помощь
на каждом этапе пути к здоровью



С 1996 года

Международная помощь и медицинские услуги повышенного комфорта

Индивидуальные обследования
Лечение и современные операции
Постоянные палаты и наблюдение



Условная иллюстрация медицинской помощи

Для взрослых пациентов · Кампус Шуйси, Тяньцзинь

Содержание

Выберите раздел: названия в оглавлении открывают соответствующую страницу.

Знакомство с Международным медицинским центром	4
История больницы и международной помощи	5
Непрерывное ведение с учетом состояния пациента	6
Индивидуальное комплексное обследование	7
Обследование с гастроскопией и колоноскопией	8
Обследование сердечно-сосудистой системы	9
Здоровье пожилых и сочетание заболеваний	10
Помощь по вопросам трансплантации органов	11
Трансплантация островковых клеток и наблюдение	12
Заболевания сердца	13
Заболевания сосудов и сердечно-сосудистый риск	14
Заболевания головного мозга и нервной системы	15
Заболевания ЖКТ и эндоскопическое лечение	16
Печень, желчные пути и поджелудочная железа	17
Заболевания дыхательной системы и грудной клетки	18
Заболевания почек и мочевой системы	19
Заболевания костей, суставов и позвоночника	20
Эндокринные и обменные заболевания	21
Ревматические и иммунные заболевания	22
Женское здоровье и репродуктивная медицина	23
Офтальмология, ЛОР и стоматология	24
Дерматология и реконструктивная хирургия	25
Молочная железа, щитовидная железа и общая хирургия	26

Комплексная онкологическая помощь	27
Болезни крови и клеточная терапия	28
Реабилитация и лечение боли	29
Традиционная китайская медицина	30
Инфекции и лихорадка неясного происхождения	31
Крупные операции и интенсивная терапия	32
Визуализация и функциональная диагностика	33
Процедуры под визуальным контролем и точная диагностика	34
Уход, сопровождение и языковая помощь	35
От заявки до наблюдения после выписки	36
Стационар и повседневный уход	37
Контакты и материалы для пациентов	38

Знакомство с Международным медицинским центром



Условная иллюстрация

С октября 1996 года Международный медицинский центр Первой центральной больницы Тяньцзиня специализируется на помощи иностранным пациентам и медицинских услугах повышенного комфорта. Взрослым пациентам из Китая и других стран предлагаются оценка здоровья, диагностика и лечение, стационарная помощь, рекомендации по реабилитации и дальнейшее наблюдение.

Постоянные палаты и команда: от лечения заболевания до длительного наблюдения.

Опыт международной медицинской помощи

За почти три десятилетия Центр принял более 10 000 иностранных пациентов примерно из 90 стран. Он участвовал в медицинском обеспечении международных участников Олимпийских игр 2008 года в Тяньцзине и саммита ШОС 2025 года. Межъязыковое общение, ведение сложных заболеваний и учет культурных особенностей входят в повседневную работу.

Лечение и наблюдение силами Центра

В кампусе Шуйси имеются амбулаторное отделение и постоянные стационарные палаты, работает постоянная команда врачей и медсестер. Врачи учитывают заболевание, предыдущее лечение и индивидуальные потребности; медсестры наблюдают за состоянием, участвуют в лечении, уходе и обучении пациента. Специализированное лечение сочетается с повседневным ведением заболеваний.

Центр принимает взрослых: три направления обследований, комплексная помощь пожилым, лечение заболеваний различных систем и оценка по вопросам трансплантации. Педиатрический прием в настоящее время не ведется.

История больницы и международной помощи



Первая центральная больница Тяньцзиня ведет историю с 1942 года. В ее комплексной системе медицинской помощи особое место занимают трансплантология, неотложная медицина и оториноларингология с хирургией головы и шеи. С 1996 года Центр сочетает специализированную помощь иностранным пациентам и услуги повышенного комфорта с непрерывным ведением заболеваний.

1942

Основана больница Тяньхэ, предшественница нынешней больницы.

1956

Несколько медицинских учреждений и коллективов специалистов объединены в Первую центральную больницу Тяньцзиня.

1974

Созданы лаборатория лечения острой недостаточности трех жизненно важных систем и отделение интенсивной терапии; развивается неотложная и реанимационная помощь.

1994

Больнице присвоена категория III A; в том же году успешно выполнена ортотопическая трансплантация печени.

1996

Центр начинает специализированную международную помощь и услуги повышенного комфорта.

1998

Создано отделение хирургической трансплантологии, продолжено развитие трансплантационной помощи.

Организация лечения и наблюдение

Сегодня в кампусе Шуйси постоянная команда амбулаторного отделения и стационара проводит оценку здоровья, лечение, реабилитационное консультирование и дальнейшее наблюдение. Совместное ведение и необходимые ресурсы определяются по состоянию пациента.

История больницы основана на опубликованных сведениях ее официального сайта; история Центра - на описании подразделения.

Непрерывное ведение с учетом состояния пациента



Условная иллюстрация

Центр непосредственно участвует в лечении и ведении заболеваний. После общей оценки команда определяет необходимость совместного ведения специалистами с учетом сложности состояния, целей лечения и потребностей пациента. Состав команды и ресурсы меняются по мере лечения.

01 · Комплексная оценка

Уточняются симптомы, прежние диагнозы, лекарства, аллергии, операции и повседневная самостоятельность. Проверяются имеющиеся снимки, гистологические и лабораторные результаты. При нескольких заболеваниях или неясном диагнозе сначала определяются основные проблемы и приоритеты, затем - необходимые обследования и консультации.

02 · Совместная работа со специалистами

Профильная команда проводит операции, интервенционные процедуры и специальное лечение. Команда Центра участвует в ведении сопутствующих заболеваний, сверке лекарств, организации питания и реабилитации. Общее понимание состояния и целей помогает уменьшить противоречия в назначениях и повторные обследования.

03 · Место лечения определяется потребностью

Обычное лечение и уход проводятся в амбулаторном отделении и постоянных палатах Центра. При крупных операциях, тяжелом состоянии или необходимости особой защиты возможен перевод в общее ОРИТ, профильное отделение интенсивного наблюдения или специальное лечебное отделение. Возвращение в Центр возможно после выполнения соответствующих критериев; команды обеспечивают преемственность.

04 · Наблюдение после выписки

При выписке разъясняются лекарства, контрольные обследования, реабилитация истораживающие симптомы. В ближайший период связь преимущественно телефонная, в дальнейшем - по электронной почте и WeChat; частота зависит от состояния. Повторный прием, обследования или помощь по месту жительства организуются по необходимости.

Индивидуальное комплексное обследование



Условная иллюстрация

Врач Центра составляет программу исходя из истории болезни, текущих симптомов и целей пациента. При хронических заболеваниях или постоянном приеме лекарств обследование включает оценку контроля болезни, обоснованности терапии и дальнейшего наблюдения.

01 · Кому подходит

Взрослым, желающим системно оценить здоровье, получить общее объяснение уже выполненных исследований, пересмотреть длительную терапию или оценить риски под руководством врача. При конкретных симптомах или отклонениях приоритетом становится соответствующая клиническая проблема.

02 · Как выбирают исследования

С учетом возраста, семейного анамнеза, болезней, образа жизни и имеющихся данных назначаются осмотр, анализы, УЗИ и другая необходимая визуализация. При необходимости оцениваются обмен веществ, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы, почки, кости и женское здоровье. Для последовательной комплексной оценки может рассматриваться госпитализация.

03 · Обследование и проверка лекарств

Учитываются рецептурные и безрецептурные препараты, средства китайской медицины и добавки. Оцениваются контроль болезни, взаимодействия и функция печени и почек. При необходимости врач меняет схему и объясняет причины, прием и контроль. Не прекращайте постоянные лекарства самостоятельно ради обследования.

04 · Практический план здоровья

Врач обобщает существенные отклонения и приоритеты, объясняет результаты, дает рекомендации по питанию, физической активности и образу жизни. При показаниях организуется специализированное лечение; при наблюдении уточняются исследования, сроки и способ связи.

Состав обследования и необходимость госпитализации определяются индивидуально. Одинакового фиксированного набора исследований для всех пациентов нет.

Обследование с гастроскопией и колоноскопией



Условная иллюстрация

Основу составляет оценка пищевода, желудка и толстой кишки с учетом симптомов, прежних полипов или опухолей, семейного анамнеза и результатов обследований. При подходящих полипах или других изменениях после предварительного обсуждения и оценки могут быть организованы эндоскопическое лечение и гистология.

01 · Оценка и подготовка

Врач проверяет сердечно-легочные заболевания, диабет, болезни печени и почек, риск кровотечения, опыт анестезии, прием антикоагулянтов и антиагрегантов. Питание, подготовка кишечника и изменения лекарств объясняются применительно к процедуре. Седация или анестезия выбираются после соответствующей оценки.

03 · Лечение во время исследования

Полипы, подходящие для эндоскопического удаления, после информированного согласия могут быть удалены одновременно с направлением материала на гистологию. При крупных, сложно расположенных или подозрительных на глубокую инвазию образованиях, а также повышенном риске из-за лекарств или болезней может потребоваться отдельный этап лечения либо хирургическая оценка.

02 · Эндоскопическое исследование

По показаниям выполняют гастроскопию, колоноскопию или оба исследования. Оценивают слизистую и характер изменений, при необходимости берут ткань для гистологии. Для уточнения глубины или происхождения образования может потребоваться эндоскопическое УЗИ.

04 · Результаты и дальнейшее наблюдение

После процедуры объясняют питание, активность и признаки возможного кровотечения или иных осложнений. С учетом гистологии, полноты удаления и анамнеза составляют план повторного обследования. При опухоли или предраковых изменениях подключается соответствующая команда.

Одновременное удаление зависит от поражения, подготовки, лекарств и условий процедуры. При записи сообщите о прежних полипах и антитромботической терапии.

Обследование сердечно-сосудистой системы



Условная иллюстрация

Оценка проводится по уровню риска с учетом симптомов и прежних заболеваний. Рассматриваются давление, липиды, глюкоза, строение сердца, ритм и кровоснабжение миокарда. При необходимости организуются профильные исследования и лечение.

01 · Исходный риск и состояние сердца

По анамнезу выбирают измерение давления, липидные и метаболические анализы, ЭКГ, эхокардиографию, суточное мониторирование ЭКГ или давления. При ишемической болезни, аритмии, клапанной патологии или сердечной недостаточности также оценивают контроль заболевания и лекарственную терапию.

03 · Дополнительная оценка коронарных артерий

При основаниях по анамнезу, симптомам и прежним результатам может назначаться КТ коронарных артерий. При необходимости специалист рассматривает коронарографию и дальнейшее медикаментозное, интервенционное или хирургическое лечение. Коронарография инвазивна и не является обязательной частью обследования каждого пациента.

02 · Перфузия и метаболизм миокарда

По клиническим показаниям возможно радионуклидное исследование перфузии миокарда (ЕСТ), в покое или с фармакологической нагрузкой. ПЭТ/КТ метаболизма миокарда используется для отдельных задач оценки обмена и жизнеспособности. Эти исследования дают разную информацию; подходящий метод выбирает врач.

04 · Длительное управление риском

По результатам определяют цели контроля давления, липидов, глюкозы и массы тела, проверяют лекарства и физическую активность. Для длительного лечения составляют план контроля и наблюдения. При боли в груди, обмороке или выраженной одышке следует своевременно обращаться за медицинской помощью.

ЕСТ, ПЭТ/КТ и коронарографию назначают по состоянию и показаниям, а не как универсальный скрининговый набор.

Здоровье пожилых и сочетание заболеваний



Условная иллюстрация

Комплексная помощь пожилым и ведение нескольких заболеваний - давние приоритеты Центра. При сочетании сердечно-сосудистых, обменных, дыхательных, неврологических, почечных и других болезней учитываются их контроль, повседневная активность, питание и личные жизненные цели.

01 · Общая оценка и приоритеты

Уточняются основные болезни, недавние изменения, госпитализации, сон, настроение, когнитивные функции и самостоятельность. Определяют, что требует первоочередного лечения, а что допускает наблюдение. При необходимости специалисты совместно составляют выполнимый поэтапный план.

03 · Питание и сохранение функций

Оцениваются изменения веса, аппетит, глотание, переносимость нагрузки, мышечная сила и риск падения. По необходимости назначают нутритивную поддержку, упражнения и реабилитационные рекомендации. Вместе с сестринской командой определяют помощь при еде, перемещении, ходьбе и повседневном уходе.

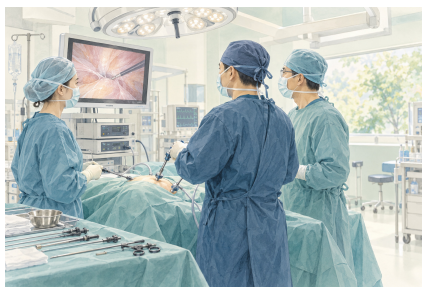
02 · Единая проверка всех лекарств

Сопоставляются назначения разных больниц и специалистов: показания, дозы и время приема. Проверяются дублирование, взаимодействия и изменения функции печени и почек. При риске гипотонии, гипогликемии, кровотечения или падения цели лечения адаптируются к индивидуальному состоянию.

04 · Стационар и дальнейший уход

Для комплекса обследований, изменения терапии или краткого наблюдения может рассматриваться госпитализация. Перед выпиской пациенту и основному ухаживающему объясняют ключевые проблемы, изменения лекарств и контроль. Длительное наблюдение учитывает симптомы, функции и качество жизни.

Помощь по вопросам трансплантации органов



Условная иллюстрация

Трансплантология - важное направление Первой центральной больницы Тяньцзиня. Центр связывает лечение терминальной органной недостаточности, профильную оценку, периоперационную помощь и длительное наблюдение. Возможность принятия заявки на трансплантацию рассматривается индивидуально.

Трансплантация органов и длительное ведение заболеваний

Заболевания

Терминальные заболевания печени • Терминальные заболевания почек • Терминальная недостаточность сердца, легких и других органов • Потребность в оценке трансплантации поджелудочной железы или тонкой кишки • Поражение нескольких органов и проблемы после трансплантации

Обследование

Функция органов и основное заболевание • Инфекции, опухоли и переносимость лечения • Оценка трансплантологом и проверка условий приема

Трансплантационная помощь

Направления больницы включают трансплантацию печени, почки, сердца, легких, поджелудочной железы, тонкой кишки и комбинированные трансплантации. Путь лечения определяется трансплантационной командой в каждом случае.

Совместное периоперационное ведение

Центр взаимодействует с трансплантационной командой при оценке, операции и длительном лечении; участвует в ведении сопутствующих болезней, питании, реабилитации и уходе.

Лечение основной болезни и поддержка органов

Если трансплантация пока не подходит или не требуется, продолжают лечение основной болезни, поддержку функций органов, экстракорпоральное очищение крови и ведение осложнений.

Профильное отделение и последующий контроль

Операция и раннее восстановление могут проходить в специализированных палатах или отделении трансплантационной интенсивной терапии. Далее контролируются функция органов, инфекции и иммуносупрессивная терапия.

Организация лечения и наблюдение

Трансплантация должна соответствовать законодательству Китая, этическим нормам и правилам приема. Иностранцам необходимо заранее предоставить документы, удостоверяющие личность, и полные медицинские сведения. Возможность приема, сроки и место лечения подлежат проверке.

Трансплантация островковых клеток и наблюдение



Условная иллюстрация

Трансплантация островковых клеток и длительное наблюдение после трансплантации - разные этапы помощи. Первая требует специальной оценки диабета и необходимых условий; второе касается функции трансплантата, лекарств, инфекционных рисков и повседневного здоровья.

Трансплантация островковых клеток

Заболевания

Диабет с потребностью в оценке для трансплантации островковых клеток • Нарушения функции органа и лекарственные вопросы после трансплантации • Сочетание хронических болезней после трансплантации

Обследование

Тип диабета и функция островковых клеток • Колебания глюкозы и эпизоды гипогликемии • Осложнения и переносимость лечения • Данные о прежней трансплантации и лекарствах

Трансплантация островковых клеток

Больница оказывает помощь по этому направлению. Специалисты определяют критерии применимости, метод, возможную пользу, риски и требования к длительному наблюдению.

Контроль глюкозы и осложнений

План учитывает текущие препараты, записи глюкозы и осложнения. Эта технология не является обычным лечением для всех пациентов с диабетом.

Специальное наблюдение после трансплантации

В зависимости от трансплантированного органа назначаются контроль его функции, визуализация, обследование на инфекции и необходимое определение концентраций лекарств. При нарушениях функции подключается трансплантолог.

Комплексное длительное ведение

Контролируют давление, глюкозу, липиды, функцию почек, здоровье костей и питание. Иммуносупрессоры и другие ключевые препараты изменяет ответственная команда.

Организация лечения и наблюдение

Конкретные вмешательства должны соответствовать законодательству Китая и применимым правилам. Заранее предоставьте полные медицинские данные: профильная команда проверит условия приема и возможность организации лечения.

Заболевания сердца



Условная иллюстрация

При ишемической болезни сердца, аритмиях, сердечной недостаточности, клапанных пороках и легочной гипертензии выбирается сочетание лекарственных, интервенционных и хирургических методов. При нескольких хронических болезнях также оцениваются переносимость лечения и потребности восстановления.

Заболевания

Ишемическая болезнь и сложные коронарные поражения • Аритмии • Сердечная недостаточность • Клапанные пороки • Некоторые врожденные пороки у взрослых • Легочная гипертензия и связанная дисфункция правых отделов

Обследование

ЭКГ и мониторинг ритма • Эхокардиография и гемодинамика • Коронарография, IVUS, OCT, FFR

Коронарные вмешательства и шунтирование

Баллонная ангиопластика, стентирование и ротационная атерэктомия подходящих кальцинированных поражений. При необходимости операции рассматриваются коронарное шунтирование, малоинвазивные, робот-ассистированные или гибридные подходы.

Абляция и кардиостимуляция

Электрофизиологическая оценка, катетерная радиочастотная абляция и постоянный кардиостимулятор; при соответствующих условиях - имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ICD) и сердечная ресинхронизирующая терапия (CRT).

Клапаны и структурные пороки

Пластика или замена клапанов, подходящие малоинвазивные и робот-ассистированные операции. При отдельных поражениях аортального клапана оценивается TAVI/TAVR, при некоторых врожденных пороках у взрослых - закрытие дефекта окклюдером или операция.

Легочная гипертензия и PADN

Оцениваются причина, функция сердца и гемодинамика. У отдельных подходящих пациентов может рассматриваться денервация легочной артерии (PADN, радиочастотная абляция). Решение зависит от типа заболевания, прежней терапии и условий программы; требуется предварительная консультация.

Лекарства и функция сердца

По функции сердца, водному балансу и сопутствующим болезням составляется план длительной лекарственной терапии, контроля факторов риска и кардиореабилитации.

Наблюдение после лечения

После лечения проверяют антитромботическую и другую терапию, рану и осложнения, планируют повторную оценку функции сердца и восстановление активности. После сложных операций или по необходимости используется соответствующее отделение интенсивного наблюдения.

Заболевания сосудов и сердечно-сосудистый риск



Условная иллюстрация

Помощь охватывает аорту, периферические артерии и вены. Артериальная гипертензия, нарушения липидного обмена и общий сердечно-сосудистый риск ведутся отдельно, во взаимосвязи с заболеваниями сердца, почек и обмена веществ.

Катетерная ренальная денервация (RDN)

Заболевания

Аневризма и расслоение аорты • Стеноз или окклюзия периферических артерий • Варикозная болезнь и венозный тромбоз • Отдельные случаи тромбоэмболии легочной артерии • Диабетическая стопа и сложные раны • Гипертензия и дислипидемия

Обследование

Визуализация сосудов и кровоснабжение • Риск тромбоза и кровотечения • Суточное давление, функция сердца и почек • Метаболические факторы риска

Аорта и периферические артерии

Эндопротезирование аорты, баллонная ангиопластика, стентирование и отдельные методы обработки бляшек. По характеру поражения рассматриваются открытые и гибридные операции, сложные вмешательства на корне или дуге аорты.

Вены и тромбоз

При варикозной болезни возможны эндовенозная лазерная облитерация, склеротерапия и другие методы. При тромбозе, венозном стенозе и отдельных случаях ТЭЛА рассматривают антикоагуляцию, катетерный тромболитизис, вмешательства или фильтр.

Восстановление кровотока и лечение ран

С учетом кровоснабжения, нейропатии и инфекции выбирают подходящую реваскуляризацию, местное лечение, контроль глюкозы и реабилитацию.

Интервенционное лечение гипертензии: RDN

По показаниям возможна катетерная денервация почечных артерий (RDN), включая радиочастотную абляцию. До процедуры оцениваются давление, прежние лекарства, функция почек и почечные артерии. После нее продолжают контроль давления, коррекцию терапии и длительное наблюдение.

Организация лечения и наблюдение

Контроль учитывает кровотечение, повторный тромбоз, заживление и активность; ведутся давление, липиды и обменные риски. При подозрении на вторичную гипертензию уточняется причина. Метод зависит от анатомии сосудов, поражения и общего состояния.

Заболевания головного мозга и нервной системы



Условная иллюстрация

Направления включают сосудистые заболевания мозга, опухоли мозга и спинного мозга, эпилепсию, двигательные и когнитивные нарушения, периферические невропатии и связанные функциональные проблемы. По причине и характеру поражения сочетаются лекарства, вмешательства, микрохирургия и реабилитация.

Наблюдение и реабилитация после крупных операций

Заболевания

Цереброваскулярные болезни и аневризмы • Опухоли мозга, основания черепа и спинного мозга • Эпилепсия, болезнь Паркинсона и другие двигательные нарушения • Невралгия тройничного нерва • Когнитивные нарушения, головная боль и головокружение • Периферические нервные и связанные со сном нарушения

Обследование

Сосудистая визуализация и перфузия мозга • Видео-ЭЭГ и электромиография • Когнитивные и неврологические функции • Необходимый интраоперационный электрофизиологический мониторинг

Сосудистые вмешательства и операции

У подходящих пациентов рассматриваются эндоваскулярное лечение или микрохирургическое клипирование аневризм, каротидная эндартерэктомия и экстраинтракраниальное шунтирование. Одновременно уточняются причины инсульта и контролируются факторы риска.

Микрохирургия и нейроэндоскопия

При опухолях мозга, основания черепа и спинного мозга оцениваются микрохирургическое удаление, нейроэндоскопия или стереотаксические операции. Сложные поражения основания черепа ведутся совместно профильными специалистами.

Лечение функциональных нарушений

В зависимости от состояния рассматриваются лекарства, глубокая стимуляция мозга, микроваскулярная декомпрессия и другие подходы с учетом контроля симптомов и сохранения функций.

Нейрореабилитация и наблюдение

После лечения планируется восстановление движения, глотания, речи, когнитивных функций и бытовой активности. Хронические неврологические симптомы оцениваются в динамике.

Организация лечения и наблюдение

После крупных нейрохирургических операций может понадобиться лечение в общем ОРИТ больницы или профильном отделении интенсивного наблюдения. При остром инсульте требуется немедленная неотложная помощь.

Заболевания ЖКТ и эндоскопическое лечение



Условная иллюстрация

При заболеваниях пищевода, желудка, кишечника и некоторых панкреатобилиарных состояниях сочетаются оценка симптомов, эндоскопия, гистология и малоинвазивное лечение. При необходимости хирургического или комплексного онкологического лечения подключаются профильные команды.

EMR · ESD · ERCP · POEM

Заболевания

Рефлюкс, боль в животе и нарушения стула • Кровотечение и стенозы ЖКТ • Полипы и ранние опухоли • Подслизистые образования • Ахалазия кардии • Некоторые заболевания поджелудочной железы, желчных путей и тонкой кишки

Обследование

Гастроскопия, колоноскопия и гистология • Эндоскопическое УЗИ • Капсульная эндоскопия тонкой кишки по показаниям • Анализы, визуализация и оценка питания

Удаление полипов и ранних поражений

Для подходящих поражений рассматриваются эндоскопическая резекция слизистой (EMR) и диссекция в подслизистом слое (ESD). При подслизистых образованиях возможна оценка эндоскопической энуклеации, туннельной или полнослойной резекции.

Панкреатобилиарная эндоскопия

Удаление камней, дренирование и стентирование при ЭРХПГ (ERCP); эндоскопическое УЗИ и подходящие пункционные или дренирующие вмешательства.

Функциональные и неотложные вмешательства

При ахалазии рассматривается пероральная эндоскопическая миотомия (POEM). По состоянию проводятся эндоскопический гемостаз, стентирование стенозов ЖКТ и другие вмешательства.

Хирургия ЖКТ и комплексное лечение

Для опухолей, не подходящих для эндоскопического лечения, неотложных и других хирургических заболеваний оценивают лапароскопическую или открытую операцию с последующим онкологическим лечением при необходимости.

Организация лечения и наблюдение

После удаления гистология помогает оценить полноту лечения и дальнейшую тактику. Организируются питание, восстановление и контроль. Метод эндоскопии выбирается по глубине, расположению и рискам поражения.

Печень, желчные пути и поджелудочная железа



Условная иллюстрация

При опухолях печени, болезнях желчных путей и поджелудочной железы, гепатолитиазе, портальной гипертензии и патологии селезенки план учитывает функцию органов, распространенность и общее состояние. Сложные случаи могут требовать совместного обсуждения хирургии, эндоскопии, интервенционных методов и системной терапии.

Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция (Whipple)

Заболевания

Опухоли печени • Рак поджелудочной железы и поражения головки или периампулярной зоны • Камни внутрипеченочных протоков и заболевания желчных путей • Панкреатит и его осложнения • Портальная гипертензия и патология селезенки

Обследование

Функциональный резерв печени • Трехмерное планирование и интраоперационное УЗИ • Распространенность опухоли и сосуды • Питание, инфекция и переносимость операции

Лапароскопическая операция Уиппла

При раке поджелудочной железы и других соответствующих показаниям поражениях головки или периампулярной зоны может выполняться лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция. Решение зависит от распространенности и отношения опухоли к сосудам.

Сложная резекция печени и сосудистая реконструкция

У подходящих пациентов оцениваются лапароскопия и флуоресцентная навигация. При вовлечении крупных сосудов или опухолевом тромбе дополнительно рассматривается возможность сложной резекции и реконструкции.

Комбинированная эндоскопия и желчные пути

По расположению камней, анатомии и прежним операциям выбирают лапароскопию, холангиоскопию, гастроинтестинальную эндоскопию либо их сочетание. При панкреатите по состоянию организуют дренирование и поддержку органов.

Местное и системное лечение

При опухолях печени, желчных путей и поджелудочной железы обсуждают последовательность абляции, интервенционного и системного лечения, включая послеоперационную противоопухолевую терапию.

Организация лечения и наблюдение

В периоперационном периоде контролируются функция печени, глюкоза, питание, инфекции и риск тромбоза. Раннее лечение после крупных операций может проходить в общем или профильном ОРИТ.

Заболевания дыхательной системы и грудной клетки



Условная иллюстрация

При легочных узлах, раке легкого, заболеваниях дыхательных путей и плевры, хронических болезнях легких и нарушениях дыхания во сне выбор между наблюдением, лекарствами, вмешательством и операцией опирается на визуализацию, функцию легких, эндоскопический материал и гистологию.

Заболевания

Узлы и рак легкого • Стеноз дыхательных путей и болезни плевры • Опухоли пищевода и средостения, болезни тимуса • ХОБЛ и астма • Нарушения дыхания во сне

Обследование

Визуализация грудной клетки и функция легких • Бронхоскопия, EBUS-TBNA • Торакоскопия и гистология • Оксид азота в выдыхаемом воздухе и исследование сна

Торакоскопия и робот-ассистированные операции

Могут рассматриваться однопортовая торакоскопия и робот-ассистированные малоинвазивные методы. При подходящем центральном раке легкого обсуждаются бронхопластические или сосудистые рукавные резекции.

Дыхательные пути и плевра

Бронхоскопическая биопсия и эндобронхиальная ультразвуковая трансbronхиальная пункция. При стенозе рассматриваются баллонное расширение или стент; при поражении плевры - диагностическая торакоскопия и биопсия.

Пищевод и средостение

При заболеваниях пищевода, средостения, тимуса и отдельных поражениях плевры оцениваются торакоскопические и другие операции с учетом дыхательной функции и питания.

Хронические болезни и сон

Проводится обучение лекарственной терапии и использованию ингаляторов. По результатам исследования сна выбирают лечение, учитывая ночную гипоксемию и сердечно-сосудистые последствия.

Организация лечения и наблюдение

При узлах легкого наблюдение, забор материала или операцию выбирают по динамике снимков и риску. Лечение опухоли зависит от стадии и гистологии; далее организуются дыхательная реабилитация и контроль.

Заболевания почек и мочевой системы



Условная иллюстрация

Комплексно оцениваются сохранение функции почек, структурные нарушения мочевой системы и заболевания, требующие операции. Помощь включает острые и хронические болезни почек, камни, урологические опухоли, заболевания простаты и нарушения мочеиспускания.

Заболевания

Острые и хронические болезни почек • Камни мочевых путей • Опухоли почки, мочевого пузыря и простаты • Гиперплазия простаты и расстройства мочеиспускания • Стрессовое недержание мочи у женщин • Мужские репродуктивные проблемы

Обследование

Функция почек, анализы мочи и визуализация • Биопсия почки при необходимости • Мочеиспускание и остаточная моча • Спермограмма и репродуктивные исследования

Очищение крови и лечение почек

По состоянию применяются гемодиализ, гемодиализация, непрерывная заместительная почечная терапия, плазмообмен и подходящие методы иммуноадсорбции. Для перитонеального диализа оцениваются установка катетера и дальнейшее ведение.

Операции при урологических опухолях

При опухолях почки, мочевого пузыря и простаты рассматриваются робот-ассистированные, лапароскопические или открытые операции с учетом контроля опухоли и сохранения функций.

Камни и нарушения мочеиспускания

При камнях оцениваются гибкая уретероскопия и перкутанная нефролитотомия. При гиперплазии простаты выбирают лекарства или операцию в зависимости от причины; при стрессовом недержании может рассматриваться малоинвазивная sling-операция.

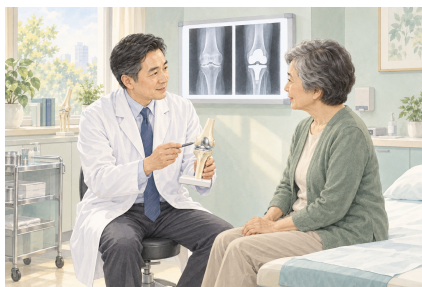
Мужская репродуктивная микрохирургия

У подходящих пациентов оцениваются микрохирургическая коррекция варикоцеле, извлечение сперматозоидов из яичка и другие методы с участием специалистов репродуктивной медицины.

Организация лечения и наблюдение

Контролируются функция почек, инфекции и мочеиспускание. Помощь по трансплантации почки описана в разделе о трансплантации органов. Метод операции зависит от расположения, стадии и общей переносимости.

Заболевания костей, суставов и позвоночника



Условная иллюстрация

При боли, ограничении движения и структурном повреждении оценивается применимость консервативного, малоинвазивного или хирургического лечения. При болезнях сердца и легких, диабете или остеопорозе одновременно планируются управление периоперационными рисками и восстановление функций.

Заболевания

Тяжелые заболевания тазобедренного и коленного суставов • Некроз головки бедренной кости • Повреждения плечевого и коленного суставов • Дегенеративные болезни позвоночника и дисков • Переломы и патология кисти и стопы • Вальгусная деформация первого пальца стопы

Обследование

Визуализация и функция костей и суставов • Источник боли и неврологические функции • Здоровье костей и периоперационный риск

Эндопротезирование суставов

По характеру поражения и потребностям движения оценивается замена тазобедренного, коленного или пателлофemorального сустава. Функциональные цели и план реабилитации определяются до лечения.

Артроскопия

При поражениях плечевого и коленного суставов рассматриваются артроскопия и другие подходящие методы с учетом стабильности, послеоперационной защиты и тренировок.

Малоинвазивная хирургия позвоночника и спондилодез

По неврологической функции, визуализации и источнику боли рассматриваются микроскопические, эндоскопические, малоинвазивные стабилизирующие и другие операции.

Переломы, кисть и стопа

Проводятся оценка и лечение переломов и заболеваний кисти и стопы. У подходящих пациентов возможна оценка малоинвазивной коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы.

Организация лечения и наблюдение

У пожилых также учитываются питание, остеопороз и сопутствующие болезни. После операции контролируют рану, тромбоз, нагрузку и тренировку ходьбы. Решение об операции зависит от симптомов и функций, а не только от снимка.

Эндокринные и обменные заболевания



Условная иллюстрация

Оцениваются и лечатся диабет, заболевания щитовидной железы, гипофиза, надпочечников и костного обмена. Анализы сопоставляются с симптомами, лекарствами, питанием и образом жизни для составления длительного плана.

Заболевания

Диабет и его осложнения • Нарушения функции и узлы щитовидной железы • Болезни гипофиза, надпочечников и паращитовидных желез • Ожирение, нарушения липидов и мочевой кислоты • Остеопороз и нарушения костного обмена

Обследование

Колебания глюкозы и риск гипогликемии • Гормоны, УЗИ, КТ или МРТ • Почки, глазное дно, нервы и стопы • Плотность костей и вторичные причины

Глюкоза и осложнения диабета

Схема корректируется с учетом текущего лечения, колебаний глюкозы и риска гипогликемии. При инфекции, операции или остром заболевании организуются соответствующие наблюдение и лечение.

Специальная эндокринная помощь

Назначаются препараты по заболеванию. При необходимости операции, радионуклидной или иной специальной терапии план разрабатывается совместно с профильной командой.

Вес и обмен веществ

С учетом питания, активности, сна, сопутствующих болезней и лекарств даются рекомендации по образу жизни и назначается медикаментозная терапия при наличии показаний.

Сохранение здоровья костей

Составляется план лекарств, питания и упражнений. При переломе или ограничении активности подключаются ортопеды, реабилитационная и сестринская команды.

Организация лечения и наблюдение

По динамике состояния пересматриваются лекарства и цели лечения, учитываются сердечно-сосудистые, печеночные и почечные риски. Трансплантация островковых клеток требует специальной оценки; см. соответствующий раздел.

Ревматические и иммунные заболевания



Условная иллюстрация

Боль в суставах, сыпь, повторная лихорадка, сухость глаз и рта или поражение нескольких органов могут требовать системной иммунологической оценки. Цели - определить активность болезни, защитить органы, контролировать симптомы и уменьшить риски длительной терапии.

Заболевания

Ревматоидный артрит и спондилоартриты • Системная красная волчанка и синдром Шегрена • Системные васкулиты и воспалительные миопатии • IgG4-ассоциированные заболевания • Подагра и остеопороз • Некоторые аутоиммунные болезни печени

Обследование

Аутоантитела и активность болезни • УЗИ суставов, МРТ и другая визуализация • Поражение легких, сердца, почек и нервной системы

Индивидуальная лекарственная терапия

Иммуномодулирующие и другие препараты выбираются по заболеванию, активности, поражению органов и прежнему лечению с постоянной оценкой эффекта.

Биологические и таргетные препараты

При соответствующих условиях рассматривается биологическая или другая таргетная терапия с учетом инфекционного риска и ответа на лечение.

Специальные методы для сложных случаев

В отдельных случаях может рассматриваться иммуноадсорбция и другие методы; условия проведения определяет профильная команда.

Защита органов и сохранение функций

Пораженные органы ведутся совместно с ответственными специалистами. Планируются защита суставов, двигательная активность и согласование лекарств в периоперационном периоде.

Организация лечения и наблюдение

Длительно контролируются инфекции, клетки крови, функция печени и почек, здоровье костей и нежелательные реакции. Диагноз основывается на совокупности клинических данных, а не на одном анализе антител.

Женское здоровье и репродуктивная медицина



Условная иллюстрация

Помощь учитывает разные этапы жизни женщины: гинекологические заболевания, патологию шейки матки, эндокринные и перименопаузальные изменения, тазовое дно и репродуктивные вопросы. При других заболеваниях план согласуется с общим состоянием.

Заболевания

Доброкачественные и злокачественные болезни матки и яичников • Патология шейки матки • Нарушения менструаций и функции яичников • Перименопаузальные и тазовые нарушения • Бесплодие • Сопутствующие заболевания во время беременности и родов

Обследование

ВПЧ, цитология шейки матки и кольпоскопия • Биопсия и гормоны при необходимости • УЗИ и другая визуализация • Репродуктивная оценка обоих партнеров и мониторинг фолликулов

Малоинвазивная гинекологическая хирургия

Гистероскопические, лапароскопические и 3D-лапароскопические методы. При гинекологических опухолях операция или системное лечение планируются по гистологии и стадии.

Шейка матки, перименопауза и тазовое дно

Лечение и наблюдение определяются по обследованию и общему здоровью. Если важно сохранить фертильность, возможности обсуждаются заранее.

Вспомогательные репродуктивные технологии

Больница применяет внутриматочную инсеминацию спермой мужа, экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов, интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоида (ИКСИ) и криоконсервацию эмбрионов.

Совместное ведение при беременности и родах

При высоком риске или сопутствующих терапевтических и хирургических заболеваниях Центр вместе с акушерами определяет место ведения. Обследования беременности, роды и специальное наблюдение организуются по требованиям акушерской службы.

Организация лечения и наблюдение

Вспомогательные репродуктивные технологии должны соответствовать законодательству Китая и профильным требованиям; иностранным пациентам следует заранее уточнить условия приема. Центр сейчас не принимает детей. Интимная пластика описана в разделе дерматологии и реконструктивной хирургии.

Офтальмология, ЛОР и стоматология



Условная иллюстрация

Эти заболевания могут влиять на зрение, слух, дыхание, глотание и общение. Учитываются не только местные изменения, но и диабет, анти тромботическая терапия и другие болезни, влияющие на операцию и восстановление.

Функциональная и эндоскопическая хирургия носа

Заболевания

Катаракта, глаукома, болезни глазного дна и роговицы • Сухой глаз и слезные пути • Хронический ринит, гипертрофия раковин, искривление перегородки • Болезни пазух и отдельные поражения основания черепа • Слух, равновесие, дыхание во сне, болезни головы и шеи • Зубы, пульпа, пародонт, челюстно-лицевые травмы и опухоли

Обследование

ОКТ, ангиография глазного дна, поля зрения и УЗИ • Слух, равновесие, сон и эндоскопия • Стоматологические и челюстно-лицевые исследования

Офтальмология

Факоэмульсификация катаракты через микроразрез с имплантацией линзы, операции при глаукоме, пересадка роговицы, витрэктомия и интравитреальные инъекции, лазерное лечение сетчатки и другие методы.

ЛОР-хирургия и основание черепа

Микрохирургия уха, эндоскопическая хирургия носа и основания черепа. У подходящих пациентов оцениваются закрытие назальной ликвореи, декомпрессия орбиты и эндоназальные вмешательства совместно с нейрохирургами.

Ринит и функциональная хирургия носа

При хроническом рините, гипертрофии раковин, искривлении перегородки и болезнях пазух план учитывает симптомы, эндоскопию и необходимую визуализацию. При сохраняющихся выраженных симптомах после стандартного медикаментозного лечения и наличии показаний рассматриваются функциональные операции на раковинах, септопластика и эндоскопическая хирургия носа и пазух с сохранением функций.

Стоматологическое восстановление и хирургия

Лечение зубов и пульпы, пародонта и слизистой; протезирование, имплантация и ортодонтическая оценка. При переломах челюстно-лицевой области, опухолях и заболеваниях слюнных желез организуется хирургическая помощь.

Организация лечения и наблюдение

При сопутствующих болезнях заранее оцениваются условия процедуры, анти тромботические препараты и инфекционный риск. После операции уточняются лекарства, питание, защита раны и контроль. При многоэтапном восстановлении или длительных инъекциях заранее обсуждаются срок пребывания и наблюдение по месту жительства.

Дерматология и реконструктивная хирургия



Условная иллюстрация

Направления включают хронические кожные болезни, рубцы, сложные раны, дефекты тканей и медицинскую пластическую хирургию. Учитываются функции, внешний вид, личные цели и операционные риски с защитой приватности и подробным обсуждением.

Пластика лица и женская интимная пластика

Заболевания

Экзема, псориаз и витилиго • Буллезные и грибковые заболевания • Пигментные, сосудистые поражения и новообразования кожи • Послеожоговые рубцы и сложные раны • Потребность в пластике лица • Женская интимная пластика и реконструкция

Обследование

Гистология кожи, иммунные и грибковые исследования • Мягкие ткани, рубцы и функции • Обсуждение целей и хирургических рисков

Лекарственное, световое и лазерное лечение кожи

В зависимости от болезни выбираются препараты, ультрафиолетовая фототерапия и подходящие лазерные методы.

Рубцы и восстановление тканей

Компрессионное и медикаментозное лечение, иссечение и рассечение рубцов, кожные трансплантаты, лоскуты и тканевая экспансия с учетом заживления и подвижности.

Медицинская пластика лица

План зависит от анатомии, кожи, мягких тканей и целей пациента. Обсуждаются возможный объем улучшения, рубцы, восстановление и риски.

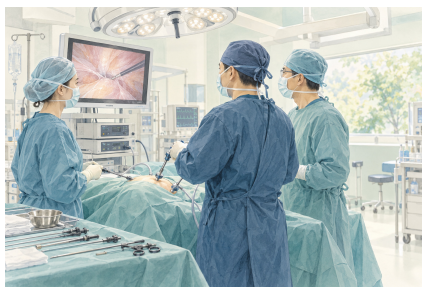
Интимная пластика, преимущественно для женщин

При изменениях формы, дискомфорте или необходимости реконструкции учитываются роды в анамнезе, местные заболевания и состояние тазового дна. При необходимости участвуют гинекологи, урологи и специалисты по тазовому дну.

Организация лечения и наблюдение

Особое внимание уделяется приватности и полноценному обсуждению. Результат зависит от индивидуальных условий, метода и восстановления. Конкретный план определяется после очного осмотра.

Молочная железа, щитовидная железа и общая хирургия



Условная иллюстрация

При заболеваниях молочной и щитовидной желез, грыжах брюшной стенки и колопроктологических проблемах сначала определяют характер поражения и потребность в лечении, затем с учетом сопутствующих болезней выбирают наблюдение, лекарства или операцию.

Заболевания

Узлы, образования и опухоли молочной железы • Узлы и хирургические болезни щитовидной железы • Паховые, послеоперационные и другие грыжи • Колопроктологические болезни • Другие абдоминальные хирургические проблемы

Обследование

УЗИ, маммография и забор материала при необходимости • Функция щитовидной железы, цитология и гистология • Размер дефекта и прежние операции • Колопроктологическое обследование

Молочная железа: хирургия и комплексное лечение

План составляется по гистологии, стадии и общему состоянию, с подключением онкологического лечения и пластической реконструкции.

Хирургия щитовидной железы

Объем удаления определяется поражением с сохранением важных структур и учетом послеоперационных функций. При необходимости радионуклидной или эндокринной терапии проводится совместная оценка.

Пластика грыж брюшной стенки

Лапароскопический или открытый метод выбирается по расположению и размеру дефекта, рецидивам и прежним операциям.

Колопроктология и другая хирургия

После уточнения причины крови в стуле, перианальной боли или нарушений дефекации обсуждаются консервативное и хирургическое лечение. Неотложные заболевания ЖКТ ведутся по состоянию.

Организация лечения и наблюдение

До операции учитываются хронический кашель, затрудненное мочеиспускание, питание и другие факторы восстановления. После нее разъясняются активность и контроль. При сильной острой боли или кровотечении своевременно обращайтесь за помощью.

Комплексная онкологическая помощь



Условная иллюстрация

Сначала уточняются морфологический диагноз, распространенность опухоли и общее состояние. Центр взаимодействует с онкологами и другими специалистами, сочетая хирургию, системное лечение, лучевую терапию и подходящие местные методы; параллельно ведутся симптомы и сопутствующие болезни.

Операция · лекарства · облучение · местное лечение

Заболевания

Злокачественные опухоли легких и молочной железы • Опухоли ЖКТ, печени, желчных путей и поджелудочной железы • Другие солидные опухоли • Рецидивы, метастазы и сложные лечебные ситуации • Симптомы лечения и нарушения питания

Обследование

Пересмотр гистологии и стадирования • Дополнительный материал и маркеры при необходимости • Визуализация, предыдущий эффект и переносимость

Системная лекарственная терапия

Химиотерапия, таргетная и иммунотерапия рассматриваются с учетом гистологии, утвержденных показаний, молекулярных исследований и функции органов. Контролируются эффективность и нежелательные реакции.

Современная лучевая терапия

Могут рассматриваться IMRT, VMAT, IGRT, SRS, SBRT и подходящие варианты интраоперационного облучения.

Хирургия и местные методы

По заболеванию организуются операция, абляция под контролем визуализации, интервенционные или ядерно-медицинские методы с совместным обсуждением последовательности лечения.

Симптомы и качество жизни

В план включают лечение боли, тошноты, недостаточного питания, инфекций и других проблем. По потребности организуются психологическая поддержка и реабилитация.

Организация лечения и наблюдение

План учитывает стадию, ответ на прошлое лечение и цели пациента. Наблюдение оценивает эффект, риск рецидива и функции. Отдельные виды лечения проводятся в соответствующем профильном отделении.

Болезни крови и клеточная терапия



Условная иллюстрация

Помощь включает анемию, цитопении, нарушения свертывания, лейкозы, лимфомы, множественную миелому, миелодиспластические и миелопролиферативные заболевания. Лечение определяется типом болезни, риском, предыдущей терапией и общим состоянием.

CAR-T и трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Заболевания

Анемия и цитопении • Нарушения кровоточивости и свертывания • Лейкозы и лимфомы • Множественная миелома • Миелодиспластические и миелопролиферативные заболевания

Обследование

Кровь и костный мозг • Тип болезни и стратификация риска • Контроль ответа, включая минимальную остаточную болезнь • Функции органов и инфекции

Системное и поддерживающее лечение

По заболеванию и риску выбирают препараты и поддержку, одновременно лечат инфекции, анемию, кровотечение и нарушения функций органов.

CAR-T-клеточная терапия

Ведется работа по направлению CAR-T. Конкретный препарат, показания, характер программы, условия приема и необходимые документы должны быть уточнены профильной командой до приезда.

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Больница располагает технологиями аутологичной и аллогенной трансплантации, включая подходящие варианты совместимой и гаплоидентичной трансплантации.

Гематологическая помощь пожилым

Интенсивность лечения, контроль и длительный уход определяются с учетом сочетания болезней, питания, активности и переносимости терапии.

Организация лечения и наблюдение

CAR-T и трансплантация должны соответствовать законодательству Китая и требованиям программы. На отдельных этапах необходимы специальные трансплантационные боксы, палаты с ламинарным потоком или интенсивное наблюдение. Уточните условия заранее.

Реабилитация и лечение боли



Условная иллюстрация

Реабилитация и обезболивание могут сопровождать восстановление и длительное ведение болезни. Оцениваются источник боли, возможности движения и жизненные цели; применяются лекарства, тренировки, физические методы и, по показаниям, интервенционные или малоинвазивные процедуры.

Заболевания

Нарушения после инсульта и другие неврологические расстройства •
Восстановление после переломов и ортопедических операций •
Функциональные проблемы после лечения ожогов • Боль в шее, плечах, пояснице, ногах и позвоночнике • Невралгия тройничного нерва и постгерпетическая невралгия •
Некоторые стойкие болевые синдромы

Обследование

Движение, бытовая активность и функции •
Источник боли и неврологические признаки •
Визуализация и ответ на прошлое лечение

Восстановление функций

Двигательная реабилитация, эрготерапия, мануальные и физиотерапевтические методы, ортезы по необходимости. Контроль согласуется с профильными специалистами.

Малоинвазивные методы против боли

По показаниям рассматриваются нервные блокады, радиочастотные методы и эндоскопия позвоночника. При остеопоротических переломах позвонков может оцениваться вертебропластика.

Трудно поддающаяся лечению невралгия

В зависимости от причины рассматриваются препараты, микробаллонная компрессия, радиочастотное лечение или стимуляция спинного мозга с учетом функций, рисков и последующего обслуживания.

Возвращение к обычной жизни

Разъясняются безопасная ходьба, перемещение, функциональные упражнения и вспомогательные средства. Стационарные занятия связываются с целями домашнего ухода.

Организация лечения и наблюдение

Нагрузка меняется по боли, функциям и выносливости. При длительном постельном режиме и восстановлении после тяжелой болезни также учитываются питание и кожа. Цели согласуются с повседневными потребностями пациента.

Традиционная китайская медицина



Условная иллюстрация

Традиционная китайская медицина (ТКМ, TCM) является важной частью китайской медицинской традиции. По потребности Центр может организовать оценку специалистом ТКМ, согласуя ее методы с текущим лечением, реабилитацией и лекарствами.

Индивидуальный подход ТКМ и длительное наблюдение

Методы ТКМ

Растительное сырье для отваров • Готовые препараты ТКМ • Иглоукалывание и прижигание • Массаж туйна • Баночная терапия • Лечебные аппликации • Паровые процедуры • Воздействие на точки ушной раковины

Индивидуальная оценка и курс

Врач ТКМ уточняет симптомы, особенности организма, образ жизни и динамику болезни путем опроса и соответствующего осмотра. План учитывает современные диагнозы и исследования. При длительном ведении в наблюдение включаются симптомы, питание, сон и активность.

Согласование с текущей терапией

Подходящие хронические симптомы, боль и восстановительные потребности могут рассматриваться для методов ТКМ. Сообщите обо всех китайских и других лекарствах, аллергиях и антикоагулянтах. Учитываются взаимодействия, функция печени и почек, назначения и повторные приемы.

Изображение иллюстрирует прием ТКМ. Конкретные методы выбираются по состоянию и условиям их проведения.

Инфекции и лихорадка неясного происхождения



Условная иллюстрация

При повторной лихорадке, сложных инфекциях или инфекции на фоне иммунодефицита причину ищут с учетом течения, контактов, прежнего лечения и исследований. Центр организует инфекционную и смежную оценку, необходимую изоляцию и перевод.

Заболевания

Неясная или повторная лихорадка • Сложные инфекции и устойчивые бактерии • Грибковые и тяжелые инфекции • Инфекции после трансплантации, при болезнях крови и иммуносупрессии

Обследование

Поездки, контакты и лекарства • Микробиологические посевы и молекулярные тесты • Очаг инфекции, чувствительность и функции органов • Визуализация и неинфекционные причины

Лечение с учетом причины

Тактика определяется возбудителем, чувствительностью, очагом и прежним применением противомикробных препаратов.

Совместное ведение сложных пациентов

При иммунодефиците или сочетании болезней участвуют инфекционисты и профильные специалисты; учитываются лекарственные взаимодействия и функции органов.

Местное лечение и поддержка органов

По состоянию рассматриваются дренирование и другие местные вмешательства. При тяжелом течении своевременно организуется интенсивное наблюдение и органная поддержка.

Изоляция и перевод

При отдельных инфекционных и заразных заболеваниях требуется изоляция. Даже после поступления в Центр может понадобиться перевод в специализированную инфекционную больницу с учетом возбудителя, условий изоляции и потребностей лечения.

Организация лечения и наблюдение

При записи сообщите о недавней лихорадке, контактах, известных заразных заболеваниях и результатах на устойчивые бактерии. При одышке, низком давлении или изменении сознания своевременно обращайтесь за неотложной помощью.

Крупные операции и интенсивная терапия



Условная иллюстрация

Сложные операции и лечение критических состояний требуют участия хирургов, анестезиологов, реаниматологов и других специалистов. Центр согласует место лечения и ресурсы по состоянию пациента; после стабилизации продолжает реабилитацию, ведение сопутствующих болезней и подготовку к выписке.

01 · Периоперационная оценка

До операции оцениваются сердце и легкие, печень и почки, питание, инфекции, риск тромбоза и кровотечения, потребность в анестезии и наблюдении. При длительном приеме антитромботических, сахароснижающих, иммуносупрессивных и других препаратов схема согласуется со специалистами.

03 · Общее ОРИТ и профильные отделения

После крупных нейрохирургических, кардиоторакальных и абдоминальных операций, а также при иных тяжелых состояниях могут потребоваться общее ОРИТ больницы, трансплантационное или другое профильное отделение. Тип койки и место определяются состоянием и условиями наблюдения. Возвращение в Центр возможно после выполнения критериев перевода.

02 · Поддержка органов

По состоянию больница применяет искусственную вентиляцию, непрерывное очищение крови, плазмообмен и соответствующую искусственную поддержку печени. По показаниям рассматривается экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Интенсивная терапия учитывает гемодинамику, УЗИ, анализы, питание, инфекции и раннюю реабилитацию.

04 · Острое ухудшение и перевод из другого региона

При резком изменении состояния в больнице своевременно запускаются лечение и консультации. Для перевода из другого региона или страны заранее предоставляются свежие данные о состоянии, жизнеобеспечении и лекарствах. Принимающая команда оценивает возможность, а способ и сроки транспортировки совместно определяют ответственные медицинские команды.

Визуализация и функциональная диагностика



Условная иллюстрация

Исследование выбирается для конкретного клинического вопроса.

Увидеть структуру. Понять функцию.

КТ / МРТ · Строение и специализированные протоколы

КТ, контрастная и сосудистая визуализация; высокопольная МРТ 3,0 Тл и специализированные последовательности. По необходимости оцениваются сосудистая стенка, мультипараметрические и динамические функциональные изображения.

ПЭТ/КТ · Метаболизм и комплексная оценка

По показаниям проводится онкологическая оценка, исследование метаболизма миокарда и мозга с сопоставлением функциональной и анатомической информации.

УЗИ · Структура, кровоток и динамика

Оценка сердца, живота, щитовидной и молочных желез, мочевой системы и других органов. Контрастирование, эластография и совмещенная визуализация могут использоваться до, во время и после трансплантации.

ЕСТ · Перфузия и функция органов

ОФЭКТ/КТ (SPECT/CT) для перфузии миокарда и мозга, а также исследования костей, почек, щитовидной железы и других органов. Метод зависит от клинического вопроса и доступности радиофармпрепарата.

Другие профильные исследования включают маммографию, денситометрию и рентгенографию. При записи сообщите о возможной беременности, имплантах, металлических инородных телах и прежних реакциях на контраст.

Процедуры под визуальным контролем и точная диагностика



Условная иллюстрация

От локализации и забора материала до морфологии и молекулярных тестов - информация для выбора лечения.

01 · Вмешательства под контролем визуализации

Под УЗИ или КТ выполняются пункционная биопсия, аспирация, катетерное дренирование и подходящие виды аблации. УЗИ может сочетаться с контрастированием и совмещением изображений. Радиочастотные, микроволновые и другие методы оцениваются по состоянию.

03 · Генетические и лекарственные исследования

По четким показаниям рассматриваются молекулярные опухолевые тесты, генетическая диагностика отдельных болезней и фармакогенетика. Определение концентраций и метаболизма лекарств помогает вести отдельные препараты, включая некоторые иммуносупрессоры.

02 · Патология и цитология

Гистология, цитология, срочное интраоперационное исследование замороженных срезов, специальные окраски, иммуногистохимия, иммунофлуоресценция и гибридизация *in situ*. Для сложных случаев возможен пересмотр материала.

04 · Сопоставление результатов

Гематологические, биохимические, иммунные, эндокринные и микробиологические результаты интерпретируются в клиническом контексте. Центр связывает важные находки с лечением и уточняет, как будут переданы еще не готовые результаты.

Заранее уточните способ передачи гистологических стекол, парафиновых блоков, исходных изображений и генетических заключений.

Уход, сопровождение и языковая помощь



Условная иллюстрация

Постоянная команда участвует в повседневном лечении, наблюдении, сверке лекарств и обучении. Уход и сопровождение определяются подвижностью, состоянием и потребностями общения.

01 · Сопровождение на исследования

Обычно сотрудник сопровождает пациента к месту исследования. Стабильных самостоятельно передвигающихся пациентов сопровождает немедицинский сотрудник. Если из-за состояния или ограниченной подвижности необходимы наблюдение и уход, после оценки назначается медсестра или другой медработник.

03 · Сестринский уход и бытовая помощь

Команда помогает выполнять лечение, объясняет лекарства, содействует движению, наблюдает питание и кожу, оценивает риск падения и другие риски. Объем бытовой помощи зависит от состояния и самостоятельности. О сопровождающем, питании и особых потребностях сообщите при записи или поступлении.

02 · Китайский и английский языки

Обычно доступно обслуживание на китайском и английском. Другие языки обсуждаются с учетом потребности и реальных ресурсов; пациент может пригласить своего переводчика. Если ни один вариант недоступен, общению помогают программы перевода. При обсуждении важного анамнеза, лекарств и лечебных решений необходимо убедиться во взаимопонимании.

04 · Приватность и документы

Уточните, каких родственников или уполномоченных лиц следует включать в общение. Без разрешения нельзя фотографировать или записывать других пациентов, персонал и лечебные действия. Обычно медицинские документы предоставляются на китайском и английском; для других языков заранее согласуйте объем, способ и срок подготовки.

От заявки до наблюдения после выписки

Обратиться в Центр можно напрямую по телефону, электронной почте или WeChat. Полные предварительные сведения помогают определить подходящий путь лечения, дополнительные исследования и подготовку к приезду.

Ближайшее наблюдение - телефон · Длительная связь - почта и WeChat · Частота по состоянию

01 · Заявка до приезда

Заполните международную заявку на медицинскую помощь, укажите симптомы, диагнозы, желаемую помощь и планируемые даты. Приложите прежние выписки, визуализацию, гистологию и список лекарств. Сообщите о языке, помощи при передвижении, сопровождающем и других потребностях. Самостоятельно выбирать все специальности не требуется.

03 · Прием и лечение в больнице

Амбулаторный прием: кампус Шуйси, 2F, зона 1; стационар: 16F, зоны A/B. После осмотра и дополнительных исследований врач уточняет план, при необходимости меняя прежние договоренности. Госпитализация оформляется по направлению и указаниям сотрудников; возьмите удостоверение личности, оригиналы медицинских документов и сведения о текущих лекарствах.

02 · Подтверждение после оценки

Центр изучает документы, при необходимости запрашивает дополнения и организует профильную оценку. После определения возможного объема приема обсуждаются амбулаторная помощь или госпитализация. При коммерческом страховании заранее предоставьте данные для проверки покрытия, разрешений и прямой оплаты. Центр не продает страховые продукты.

04 · Документы и дальнейшая связь

Перед отъездом проверьте документы, лекарства и контрольные визиты, уточните передачу еще не готовых результатов. В ближайший период связь преимущественно телефонная, в дальнейшем - по электронной почте и WeChat; частота зависит от состояния. При острых или явно усиливающихся симптомах своевременно обратитесь за помощью по месту нахождения, затем обсудите дальнейшее ведение с Центром.

Стационар и повседневный уход



Кампус Шуйси, 16F, зоны A/B. Постоянные палаты: одноместные и многокомнатные.



Пример гостиной одной из палат. Конкретные помещения и оснащение зависят от предоставленной палаты.

Личное пространство

Собственный санузел, прикроватный вызов и основные бытовые удобства. В некоторых палатах есть гостиная и комната сопровождающего. Выбор зависит от состояния и доступных мест.

Питание и уход

Лечебное, специальное и религиозно обусловленное питание обсуждается заранее. По состоянию команда объясняет лекарства, помогает двигаться, наблюдает питание и кожу.

Сопровождающий и быт

О сопровождающем или временной дополнительной койке сообщите заранее. Предоставляются больничная одежда и постельные принадлежности; уборку и неисправности можно обсудить с сотрудниками.

Изменение места лечения

При необходимости изоляции, специального трансплантационного бокса или интенсивной терапии используется подходящее отделение. Возвращение оценивается после стабилизации.

Подробности о личных вещах, сопровождающих и оснащении приведены в руководстве по госпитализации и описании палат.

Контакты и материалы для пациентов

Запись на прием и общие вопросы

+86-022-23628221

Будни 08:00-12:00 / 14:00-17:00 · время Китая

TFCH_interclinic@hotmail.com

На электронные письма обычно отвечаем в течение 48 часов.

Выходные и праздники Китая

Амбулаторный прием закрыт.

Телефон: +86-022-23626360

При неотложном состоянии обратитесь в отделение экстренной помощи или местную службу скорой помощи.

Кампус Шуйси

Тяньцзинь, район Сицин, Сиинмэнь, Баошаньсидао, 2.

天津市西青区西营门街保山西道2号

Амбулаторный прием: 2F, зона 1.

Стационар: 16F, зоны A/B.

WeChat Международного медицинского центра



Прием · последующая связь · обратная связь

Через WeChat можно задать вопросы о приеме и состоянии, поддерживать связь после лечения, оставить отзыв и получить заявку, амбулаторное руководство, руководство по госпитализации и описание палат.

При первом обращении кратко опишите основную проблему, желаемую помощь и способ связи с вами.

Отсканируйте для связи с Центром

Составление и дизайн © 2026 Xuejin (Eric) Gao.

Иллюстрации показывают условные медицинские ситуации. Изображения кампуса и палат перенесены из существующих материалов.